

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22232865388 | 333

APARECIDA MARIA SANTOS

IDADE: 60 PESO: 89 ALTURA: 163 PROFISSÃO: *de lar*
SINTOMAS: *Doz de cabeça, reflexo*
QUEIXAS: *Ronco, cansaço, perda de memória*
MEDICAMENTOS: *candesartan*
MÉDICO: *Dr. Ricardo Carvalhanti*
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N
EXERCÍCIO FÍSICO: *caminhada todos os dias*
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 7h ALMOÇO: 12h LANCHE: - JANTAR: 19h
HORA QUE DORME: 22h HORA QUE ACORDA: 4h
COCHILO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: *dx*
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: MALLAMPATI: *II* IAH: 27,6 SPO2: 81%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: *HAS*
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA HAS
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA (N) OUTROS

Pico (S)

17/05 - Avaliação

24/05/24 P = 4-10 cmH₂O P₉₅: 10 cmH₂O med: 8.5 cmH₂O
IAH = 0,8 e/h
m de uso: 4h 38m Detina a máscara durante a noite
fugas: 11 el m
Natacha

07/06 P = 9,8 cmH₂O
24 IAH = 1,0 e/h Bem adaptada
m de uso: 7h 15m
fuga: 14,9 el m (percentil)

21/06 P = 9,8 cmH₂O Natacha
24 IAH = 0,9 e/h
m de uso: 7h 45' fua.
Fuga = 0,0 lpm.

12/07 P = 9,8 cmH₂O
24 IAH = 1,5 e/h fua.
m de uso: 7h 47'
Fuga = 5,5 lpm.

16/08/24 $P = 9,8 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1,5 \text{ e/h}$
m de uso: 7h32'
fuga: 7,6 l/m

Bem adaptada
S/queixos
Natasha

15/10/24 $P = 9,8 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1,8 \text{ e/h}$
m de uso: 6h 29'
fuga: 11,2 l/m

Bem adaptada
Natasha

15/01
25 $P = 9,8 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1,6 \text{ e/h}$
Fuga = 13,7 lpm
m. de uso: 6h 50'

boa claudia

12/03/25 $P = 9,8 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1,5 \text{ e/h}$
m de uso: 6h 39'
fuga: 29,7 l/m

Bem adaptada

Natasha

11/06
25 $P = 9,8 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1,6 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h
fuga = 14,5 lpm.

Nome: APARECIDA MARIA SANTOS

Data de Nascimento: 30-5-1964

IMC: 33,50

Sexo: Feminino

Data do exame: 17-04-2024

Peso: 89 kg

Altura: 1,63 m

Médico: DR. RICARDO CAVALCANTE

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 17-04-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 508,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 10,0 e 211,5 minutos. O tempo total de sono foi de 400,5 min, eficiência de 78,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,7%; estágio N2: 50,7%; estágio N3: 24,1%; sono REM: 23,5%. O índice de despertares foi de 7,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 27,6/hora, sendo 44 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 123 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 81%, permanecendo 4,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 100 bpm e NREM de 58 - 95 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 27,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=81%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. número de despertares breves normal;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (50,8/hora);
9. registro de ronco durante o sono.

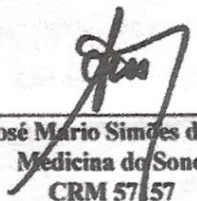
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57